

심리상담의 정신건강전문요원 공통업무화 추진 반대 성명서

보건복지부가 2026년 9월 7일 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 시행령」 일부개정령안을 입법예고하여, 정신건강전문요원 전체의 공통업무에 '국가, 지방자치단체 등에서 시행하는 심리상담 및 재난심리지원 사업의 수행'을 추가하려 한다.

우리는 개정안 내용 중 '심리상담 사업의 수행'을 정신건강전문요원 전체의 공통업무로 추가하는 부분에 대해 깊은 우려를 표하며, 해당 개정안을 원점에서 재검토할 것을 요구한다. 무엇보다 현재 개정안은 심리상담이 무엇을 의미하는지, 어디까지를 포함하는지, 각 직역이 어떠한 수준의 개입을 수행할 수 있는지, 위해가 생기면 누가 책임지는지에 대한 기준을 제시하지 않고 있다. 즉, 심리상담의 정의와 업무의 경계가 전혀 제시되어 있지 않다. 이렇게 무책임한 정책 추진이 어디에 있는가?

심리상담의 정의가 부재한 정책 추진은 혼선을 초래할 수밖에 없다.

'심리상담'은 초기면담, 정서적 지지, 생활상의 어려움에 대한 상담적 개입에서부터 자살위험 평가와 개입, 장기 심리치료, 복합적 정신병리에 대한 전문적 개입에 이르기까지 위험도와 난이도가 전혀 다른 활동들을 포괄한다.

이번 개정안은 이처럼 질적으로 전혀 다른 활동들을 구분하지 않은 채, 국가, 지방자치단체 등이 시행하는 '심리상담 사업의 수행'이라는 하나의 법정 공통업무로 규정하려 한다. 결국 해당 사업에서 무엇을 심리상담으로 보고, 어떤 개입을 누가 어느 수준까지 제공할 수 있는지는 현장의 실무자와 사업 수행기관이 판단해야 한다.

더욱이 현행 시행령 별표 2는 정신건강임상심리사의 개별업무로 '정신질환자등과 그 가족에 대한 심리 상담 및 심리 안정을 위한 서비스 지원'을 명시하고 있다. 이 조항을 그대로 둔 채 정신건강전문요원의 공통업무에 '심리상담 사업의 수행'을 추가한다면, 개별업무로서의 심리상담과 공통업무로서의 심리상담 사업 수행은 어디에서 구분되는가? 이러한 업무의 경계와 책임을 명확히 하지 않은 채 두 규정을 병존시키는 것은 현장의 혼선을 더욱 키우고, 국민에게 안전한 심리상담을 기대하기 어렵게 만든다.

심리상담은 충분한 수련과 지도감독이 이뤄져야 안전한 개입이 된다. 그러므로 이를 공통업무로 확대하기 위해서는 '적어도' 다음 내용이 갖춰져야 한다. 이는 상담의 범위와 수행

가능한 개입 수준, 개입을 선택할 때 근거가 되는 평가 역량, 개인 및 집단 상담의 사례경험 요건, 지도감독자의 자격, 수련생 역량을 평가하는 방식, 비밀보장과 기록관리, 내담자에게 위해가 발생했을 때의 책임 소재다. 이번 개정안은 이 가운데 단 한가지라도 담고 있는가? 준비는 빠진 채 업무의 범위만 넓히면, 실무자가 개입의 책임을 떠안고 내담자는 그 위험을 대신 감수하게 된다.

개별 전문가의 헌신이 제도적 교육과 수련의 공백을 대신할 수는 없다.

보건복지부는 정신건강전문요원이 2024년부터 시행된 심리상담 바우처사업의 서비스 제공 인력에 포함되어 왔다는 점을 이번 개정의 근거로 들고 있다. 그러나 특정 사업과 현장에서 정신건강전문요원들이 업무를 수행해 왔다는 사실과, 해당 업무를 모든 정신건강전문요원의 법정 공통업무로 규정하는 것은 별개의 문제다.

현장에는 이미 여러 직역의 전문요원이 상담적 개입을 하고 있고, 법정 수련을 마친 뒤에도 따로 교육과 지도감독을 받으며 상담 역량을 키워 온 이들이 있다. 우리는 그 노력을 결코 부정하지 않는다. 오히려 그런 노력이 존재한다는 것이야말로 시행령 개정이 타당하지 않다는 근거이다. 이들의 심리상담 역량은 수련만으로 얻게 된 것이 아니라, 수련을 마친 뒤에 상당한 시간과 노력을 들여 만들어낸 결과이다. 시행령 한 줄을 고치는 것으로 이러한 역량을 모두에게 보장할 수 있다고 가정해서는 안 된다.

법령은 잘 준비된 전문가를 기준으로 삼는 것이 아니라, 국민이 받는 서비스의 최소한의 안전 장치를 정하는 도구여야 한다. 심리상담을 공통업무로 포함한다고 그에 걸맞은 교육과 지도감독이 저절로 이뤄지지 않는다. 각 직역별 개별업무에 대한 수련과 기관 업무에 대한 부담으로 인해 소진된 현장에서, 모든 직역과 소속 기관이 같은 수준의 교육 훈련을 제공할 수 있으리라 기대하기는 어렵다. 핵심은 심리상담이 이미 이루어지고 있느냐가 아니라, 그것을 안전하게 해낼 최소한의 장치가 마련되어 있느냐이다.

따라서, 우리는 보건복지부에 다음을 요구한다.

첫째, 정신건강전문요원 전체의 공통업무에 '국가, 지방자치단체 등에서 시행하는 심리상담 사업의 수행'을 추가하려는 시행령 개정을 즉시 중단하고 원점에서 재검토하라.

둘째, 심리상담의 정의와 범위, 교육과 수련의 요건, 지도감독과 역량 평가의 기준을 먼저 체계적으로 세우라.

셋째, 각 지역의 심리상담 관련 교육과 수련, 사례경험과 지도감독 수준을 조사하고, 충분한 상담 역량을 갖춘 경우에만 심리상담 업무를 수행할 수 있도록 자격 기준과 절차를 제도화하라.

넷째, 정책을 일방적으로 추진하지 말고, 정신건강임상심리사를 비롯한 유관 지역의 학·협회, 수련 현장의 수련생과 지도감독자가 함께 검토하는 절차를 거쳐 국민의 안전을 담보할 기준을 마련하라.

2026년 9월 14일

서울대학교 심리학과 대학원생

임상 목정후, 이예진, 이지선, 이동현, 이충녕, 장준우, 전주리, 조선경, 최소희, 최준호, 한상준
임상상담 민혜원, 심규원, 이아롱, 임선우, 전해진, 한윤서, 황지윤 **임상신경** 강지현 곽현정,
손예림, 이현송, 임수빈, 전하진, 정서윤, 조예희, 조지현, 황희준 **계산임상** 강정윤, 신정연,
이은휘, 조유숨, 한경민